

Exantema maculopapular — diagnóstico y manejo clínico

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, British Association of Dermatologists 2024, EADV Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2024, UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

El **exantema maculopapular medicamentoso** (también llamado *exantema morbiliforme*) es la **reacción adversa cutánea más frecuente** a fármacos, representando cerca del **90%** de las erupciones medicamentosas benignas.

Se caracteriza por una **erupción eritematosa, simétrica y generalizada** que aparece típicamente **1 a 2 semanas después del inicio del fármaco**.

Aunque suele ser **autolimitado y benigno**, su importancia clínica radica en:

- La necesidad de **distinguirlo de reacciones graves** (Stevens-Johnson, DRESS, necrólisis epidérmica tóxica).
 - El potencial de **recurrencia y sensibilización cruzada**.
 - Su **frecuencia en la práctica médica y en preguntas EUNACOM**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Tipo de reacción

El exantema maculopapular corresponde a una **reacción de hipersensibilidad tipo IV (retardada, mediada por linfocitos T)**.

El proceso ocurre luego de un período de sensibilización tras exposición al fármaco, lo que explica su aparición **tardía (7–14 días)**.

2.2. Mecanismo inmunológico

1. El fármaco o su metabolito actúa como **hapteno**, uniéndose a proteínas epidérmicas.

2. Se produce una **respuesta inmune celular** (linfocitos T CD4+ y CD8+).
3. Estos liberan **citocinas proinflamatorias** (IL-4, IFN- γ , TNF- α), generando daño epidérmico y exantema.

2.3. Factores predisponentes

Categoría	Ejemplos
Fármacos más implicados	Penicilinas, cefalosporinas, sulfas, alopurinol, anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína, lamotrigina), AINES, antirretrovirales
Factores del paciente	Infección viral concomitante (p. ej. mononucleosis + amoxicilina), inmunosupresión, sexo femenino, polifarmacia
Genéticos (HLA)	HLA-B5801 (<i>alopurinol</i>), HLA-B1502 (<i>carbamazepina</i>)
Otros	Insuficiencia renal, hepatopatías, edad avanzada

2.4. Cronología típica

- **Primera exposición:** 7–14 días después del inicio del medicamento.
- **Reexposición:** aparición más rápida (1–3 días).
- **Resolución:** 5–10 días tras suspensión del fármaco.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones cutáneas

- **Exantema maculopapular simétrico**, generalizado.
- **Inicio en tronco** y progresión a extremidades.
- Lesiones:
 - Máculas eritematosas → pápulas planas y confluentes.
 - No vesiculosas ni pustulosas.
- **Respetar palmas, plantas y mucosas** (salvo progresión grave).
- Puede asociarse a **prurito, fiebre leve o malestar general**.

3.2. Características clínicas clave

- Suele presentarse entre el **5º y 14º día** del tratamiento.
- Si el fármaco ya se ha usado antes, puede aparecer en **48 horas**.
- **Desaparece sin dejar cicatriz**, aunque puede dejar descamación fina residual.
- **No hay compromiso sistémico importante** (diferencia crucial con DRESS o SJS/TEN).

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Exantema viral (p. ej. sarampión, rubéola, EBV)	Afecta niños, curso febril, presencia de adenopatías, sin relación fármaco-temporal
DRESS (síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos)	Fiebre >38°C, linfadenopatías, eosinofilia, hepatitis, erupción facial y edema

Síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica	Ampollas, erosiones mucosas, signo de Nikolsky positivo, fiebre alta
Urticaria medicamentosa	Lesiones pruriginosas evanescentes, angioedema, sin máculo-pápulas fijas
Lupus inducido por fármacos	Anticuerpos antihistonas positivos, patrón fotosensible
Pitiriasis rosada	Lesiones en “árbol de Navidad”, mácula heraldo inicial, autolimitada

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico y temporal**, basado en:

1. Inicio del exantema tras exposición a un medicamento nuevo.
2. Morfología y distribución características (simétrica, maculopapular).
3. Resolución tras suspensión del fármaco sospechoso.

4.2. Exámenes complementarios (si hay duda o gravedad)

- **Hemograma:** ocasional leucocitosis o eosinofilia leve.
- **Función hepática y renal:** para descartar compromiso sistémico (DRESS).
- **Biopsia cutánea (rara):** infiltrado linfocitario perivascular con eosinófilos.
- **Pruebas epicutáneas o test de provocación:** solo bajo supervisión especializada y cuando sea estrictamente necesario (riesgo bajo).

4.3. Criterios diagn3sticos (MINSAL / EADV 2024)

1. F3rmaco iniciado 7–14 d3as antes del inicio del exantema.
 2. Lesiones maculopapulares eritematosas sim3tricas, sin afectaci3n de mucosas.
 3. Ausencia de signos de gravedad sist3mica.
 4. Mejor3a con suspensi3n del medicamento.
-

5. Tratamiento (seg3n gu3as MINSAL / BAD / EADV)

5.1. Medidas generales

- Suspender inmediatamente el f3rmaco sospechoso.
 - Evitar f3rmacos estructuralmente relacionados (riesgo de sensibilizaci3n cruzada).
 - Evaluar medicamentos concomitantes (causa frecuente de confusi3n).
-

5.2. Tratamiento sintom3tico

S3ntoma	Manejo recomendado
Prurito leve-moderado	Antihistam3nicos orales (loratadina, cetirizina, fexofenadina)
Inflamaci3n moderada	Corticoides t3picos de potencia media (hidrocortisona, mometasona)
Erupci3n extensa o fiebre leve	Prednisona oral 0.5 mg/kg por 3–5 d3as (si es muy sintom3tico)

Sequedad o descamación Emolientes sin perfume

En general, los corticoides sistémicos se reservan para erupciones muy sintomáticas o extensas; no acortan la duración significativamente, pero mejoran el confort.

5.3. Educación del paciente

- Explicar el carácter **benigno y autolimitado** de la reacción.
 - Registrar el medicamento causante en la ficha clínica.
 - Entregar **tarjeta de alergia a medicamentos** o dejar constancia en sistema electrónico.
 - Recomendar evitar automedicación, especialmente con antibióticos y AINES.
-

5.4. Seguimiento

- Reevaluar a las 48–72 horas para verificar resolución.
 - Derivar a **dermatología o alergología** si hay dudas diagnósticas o reacción recurrente.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Progresión a reacción grave	Si el fármaco no se suspende a tiempo, puede evolucionar a DRESS o SJS
Eritrodermia medicamentosa	Afectación >90% del cuerpo; prurito intenso, fiebre, riesgo de sepsis

Reexposición accidental Reacción más intensa y rápida

Ansiedad / fobia medicamentosa Pacientes que temen usar cualquier medicamento posterior

Pronóstico:

- Excelente: resolución completa en 7–14 días tras suspensión.
- No deja secuelas ni hiperpigmentación residual significativa.
- Recidiva predecible si se reexpone al fármaco causante.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **exantema maculopapular** es la **reacción cutánea más frecuente a medicamentos**.
2. Aparece **1–2 semanas después del inicio del fármaco**.
3. **Comienza en tronco y se disemina simétricamente** hacia extremidades.
4. **No compromete mucosas** ni genera ampollas.
5. El tratamiento se basa en **suspensión del medicamento y manejo sintomático**.
6. En **EUNACOM**, suelen preguntar por la asociación **amoxicilina + mononucleosis infecciosa** → **exantema difuso**.



Errores comunes

- Confundirlo con **Stevens-Johnson** (que sí tiene ampollas y erosiones mucosas).
 - Continuar el medicamento culpable “porque la erupción es leve”.
 - Usar **antibióticos empíricamente** ante erupción sin confirmación infecciosa.
 - No registrar el fármaco en ficha → riesgo de reexposición.
 - Prescribir corticoides sistémicos prolongados innecesariamente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **exantema maculopapular medicamentoso** es una **reacción de hipersensibilidad tipo IV**, la más frecuente entre las farmacodermias.
2. Aparece típicamente **7–14 días después del inicio del fármaco**, comenzando en **tronco y diseminándose simétricamente**.
3. **No compromete mucosas ni forma ampollas**, lo que lo distingue de reacciones graves (SJS, DRESS).
4. Los fármacos más implicados son **antibióticos β -lactámicos, sulfas, AINES, anticonvulsivantes y alopurinol**.
5. El manejo consiste en **suspender el fármaco sospechoso y tratar sintomáticamente con antihistamínicos y corticoides tópicos**.
6. El pronóstico es **excelente**, con resolución completa en 1–2 semanas tras suspensión.
7. En **EUNACOM**, la clave diagnóstica:
 - “Paciente con exantema difuso, eritematoso, sin mucosas afectadas, tras uso reciente de antibióticos → exantema medicamentoso.”